

REVISIÓN

Efectividad de la auriculoterapia para reducción del estrés en personal de salud: una revisión sistemática

Effectiveness of auriculotherapy in reducing stress in healthcare personnel: A systematic review

Eficácia da auriculoterapia na redução do estresse em profissionais de saúde: uma revisão sistemática

Gema Estefanía Valenzuela-Urrea ¹

 <https://orcid.org/0000-0002-0832-7900>

Jesica Guadalupe Ahumada-Cortez ^{2*}

 <https://orcid.org/0000-0003-0092-0221>

Mario Enrique Gámez-Medina ³

 <https://orcid.org/0000-0001-8470-4782>

Rosario Eduardo Apodaca-Armenta ⁴

 <https://orcid.org/0000-0002-8144-3457>

Gustavo Alfredo Gómez-Rodríguez ⁵

 <https://orcid.org/0000-0002-3034-5443>

1. Maestra en Ciencias de Enfermería, Facultad de Enfermería los Mochis, Universidad Autónoma de Sinaloa. Los Mochis, Ahome, Sinaloa, México.
2. Doctora en Ciencias de Enfermería, Facultad de Enfermería los Mochis Universidad Autónoma de Sinaloa. Los Mochis, Ahome, Sinaloa, México.
3. Doctor en Ciencias de Enfermería, Facultad de Enfermería los Mochis Universidad Autónoma de Sinaloa. Los Mochis, Ahome, Sinaloa, México.
4. Doctor en Ciencias de Enfermería, Facultad de Enfermería los Mochis Universidad Autónoma de Sinaloa. Los Mochis, Ahome, Sinaloa, México.
5. Doctor en Ciencias de Enfermería, Facultad de Enfermería los Mochis Universidad Autónoma de Sinaloa. Los Mochis, Ahome, Sinaloa, México.

*Autor para correspondencia: jesica.ahumada.cortez@uas.edu.mx

Recibido: 08/02/2025

Aceptado: 16/09/2025

Resumen

Introducción: La salud mental del personal de salud es fundamental para asegurar una atención de calidad a los pacientes. No obstante, la carga de responsabilidades y exigencias del entorno laboral pueden generar estrés. La auriculoterapia es eficaz para reducir el estrés y favorecer el bienestar del personal de salud. **Objetivo:** Evaluar la efectividad de la auriculoterapia para la reducción del estrés en personal de salud de acuerdo a la mejor evidencia disponible. **Metodología:** Revisión sistemática con búsqueda de literatura en bases de datos como LILACS, PubMed, Cochrane Library, Scielo, Biblioteca Virtual en Salud y buscador Google Académico. Se incluyeron ensayos clínicos aleatorios entre 2012 y 2022 en idiomas español, portugués e inglés, excluyendo aquellos de metodología poco clara y dudosa. Se desarrollaron estrategias de búsqueda, se seleccionaron 10 artículos mediante Lista de Verificación de Joanna Briggs Institute, finalmente se realizó extracción y síntesis de los datos. **Resultados:** Los artículos evidenciaron que la auriculoterapia fue efectiva para la reducción del estrés. De estos, el 40 % señaló que la auriculoterapia con agujas tuvo mayor efectividad, un 20 % de los estudios indicaron que la auriculoterapia sin un protocolo específico mostró mayor efectividad según los síntomas reportados en cada consulta. En un 10 % de los estudios se observó que la experiencia del terapeuta mejoró la efectividad del tratamiento. **Conclusiones:** La auriculoterapia parece ser más efectiva para reducir el estrés en comparación con los grupos placebo y control. La auriculoterapia con agujas tuvo mayor efectividad que la auriculoterapia con semillas.

Palabras clave: Estrés laboral; Auriculoterapia; Acupuntura; Equipo de enfermería; Personal de salud; Salud ocupacional (DeCS).

Abstract

Introduction: The mental health of healthcare personnel is crucial for providing high-quality patient care. However, the demands and responsibilities of the work environment can cause stress. Auriculotherapy has been shown to be an effective way of reducing stress and promoting the well-being of healthcare personnel. **Objective:** To evaluate the effectiveness of auriculotherapy in reducing stress in healthcare personnel based on the best available evidence. **Methodology:** A systematic review was conducted by searching literature databases such as LILACS, PubMed, the Cochrane Library, SciELO, the Virtual Health Library and Google Scholar. Randomized clinical trials published in Spanish, Portuguese and English between 2012 and 2022 were included, with those with unclear or questionable methodology excluded. Search strategies were developed, and ten articles were selected using the Joanna Briggs Institute checklist. Finally, data extraction and synthesis were performed. **Results:** The articles showed that auriculotherapy is an effective way of reducing stress. Of these, 40 % indicated that needle auriculotherapy was more effective; while 20 % suggested that auriculotherapy without a specific protocol was more effective according to the symptoms reported at each consultation. It was also observed in 10 % of the studies that the therapist's experience improved the effectiveness of the treatment. **Conclusions:** Auriculotherapy appears to be more effective at reducing stress than the placebo and control groups. Needle auriculotherapy was more effective than seed auriculotherapy.

Key words: Work stress; Auriculotherapy; Acupuncture; Nursing equipment; Health personnel; Occupational health (DeCS).



Abstrato

Introdução: A saúde mental dos profissionais de saúde é essencial para garantir um atendimento de qualidade ao paciente. No entanto, a carga de responsabilidades e as demandas do ambiente de trabalho podem gerar estresse. A auriculoterapia é eficaz na redução do estresse e na promoção do bem-estar dos profissionais de saúde. **Objetivo:** Avaliar a eficácia da auriculoterapia para redução do estresse em profissionais de saúde de acordo com as melhores evidências disponíveis. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão sistemática com busca bibliográfica nas bases de dados LILACS, PubMed, Biblioteca Cochrane, Scielo, Biblioteca Cochrane, Biblioteca Virtual em Saúde e no mecanismo de busca Google Acadêmico. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados entre 2012 e 2022 em espanhol, português e inglês, excluindo aqueles com metodologia pouco clara ou duvidosa. Estratégias de busca foram desenvolvidas, 10 artigos foram selecionados usando a lista de verificação do Joanna Briggs Institute e a extração e síntese de dados foram realizadas. **Resultados:** Os artigos demonstraram que a auriculoterapia foi eficaz na redução do estresse. Destes, 40 % indicaram que a auriculoterapia com agulhas foi mais eficaz. 20 % dos estudos indicaram que a auriculoterapia sem um protocolo específico foi mais eficaz, com base nos sintomas relatados em cada consulta. 10 % dos estudos observaram que a experiência do terapeuta melhorou a eficácia do tratamento. **Conclusões:** A auriculoterapia parece ser mais eficaz na redução do estresse em comparação aos grupos placebo e controle. A auriculoterapia com agulhas foi mais eficaz do que a auriculoterapia com sementes.

Palavras-chave: Estresse no trabalho; Auriculoterapia; Acupuntura; Equipe de enfermagem; Pessoal de saúde; Saúde ocupacional (DeCS).

Introducción

Una de las principales funciones del personal de salud es brindar cuidados y atención de calidad. Sin embargo, esta responsabilidad puede desencadenar altos niveles de estrés ⁽¹⁾. El estrés que afecta la salud mental del personal de salud es un problema relevante y preocupante que conlleva desafíos culturales, económicos y sociales ⁽²⁾. Afecta negativamente la calidad, eficiencia y productividad laboral, lo que resulta en una disminución de la satisfacción de los pacientes ⁽¹⁾. Además, genera estados crónicos que afectan al cuerpo, la mente, la vida personal, familiar y educativa de quienes lo padecen ⁽²⁾.

El personal de salud a nivel mundial suele experimentar niveles de estrés hasta un 25.8 % más altos que los observados en la población general ⁽³⁾. Mientras que, en países de Latinoamérica, en promedio el 60 % presenta estrés relacionado a condiciones laborales ⁽⁴⁾. Cabe destacar que, el



personal de salud se encuentra expuesto a diversos desafíos, que incluyen las relaciones interprofesionales, el manejo del sufrimiento, dolor, muerte de los pacientes, la falta de insumos, materiales y equipos, la alta demanda, las largas jornadas laborales, situaciones de violencia, bajos salarios y condiciones laborales precarias ^(5,6). Además, la falta de oportunidades de crecimiento, el mal liderazgo de superiores y la alta exposición a enfermedades infecciosas o sustancias constituyen factores de riesgo que desencadenan altos niveles de estrés ⁽⁷⁾. El estrés es una respuesta innata y natural del organismo frente a amenazas y estímulos desafiantes, que puede presentarse en diferentes grados ⁽⁸⁾ es capaz de generar respuestas fisiológicas y psicológicas que alteran el estado normal del organismo ⁽⁹⁾.

La presencia de estímulos estresantes genera un mecanismo adaptativo de supervivencia que desencadena la liberación de hormonas como la epinefrina y la norepinefrina, las cuales incrementan la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los niveles de glucosa en sangre ⁽¹⁰⁾. Además, su manifestación recurrente puede impactar negativamente y contribuir a la aparición de problemas de salud ⁽¹¹⁾. Estos incluyen dolor corporal, falta de energía, cambios en los hábitos alimenticios, problemas del sueño, enfermedades del corazón, ansiedad, migrañas, adicciones y obesidad ^(12,13). Considerando este contexto, las Prácticas Integrativas y Complementarias de Salud (PICS) son un conjunto enfoques terapéuticos, servicios y métodos dentro del cuidado de la salud que se orientan hacia un enfoque holístico ⁽¹⁴⁾. Promueven medidas diseñadas para reducir los niveles de estrés y mejorar el estado de bienestar general del organismo ⁽⁵⁾.

Dentro de las PICS, se encuentra la auriculoterapia una técnica de la medicina tradicional China (MTC) ⁽⁶⁾ que funciona a través de la estimulación de puntos específicos en el oído ⁽¹⁵⁾. Estos puntos corresponden a diferentes partes del organismo y su estimulación es capaz producir respuestas fisiológicas como la liberación de neurotransmisores, que logran mejorar el estado de ánimo, aliviar el dolor o participar en otras funciones corporales, la liberación de citocinas, que optimiza la



función del sistema inmunológico, así como reducir la inflamación en el cuerpo y la activación de reflejos neurológicos que favorecen el equilibrio del organismo ⁽¹⁶⁾.

La auriculoterapia es eficaz en el tratamiento del estrés ^(16,17). Está respaldada por diversos estudios que han demostrado su efectividad, orientando acciones y estrategias específicamente hacia el personal de salud ^(5,18-20). Es un tratamiento simple, fácil de aplicar, económico y con poco o ningún efecto secundario ⁽¹⁵⁾.

En la revisión de la literatura realizada, no se encontró una revisión sistemática actualizada de ensayos clínicos que estudie específicamente las variables de auriculoterapia y estrés en personal de salud. Es crucial abordar esta brecha en el conocimiento pues al liderar la investigación en prácticas como la auriculoterapia, enfermería fortalecerá su contribución al avance del conocimiento en las PICS en el ámbito de la atención a la salud, consolidándose como una disciplina en la implementación de estrategias holísticas centradas en el ser humano y no únicamente en la enfermedad. La adopción de esta técnica no solo facilitará una notable reducción del estrés en el personal de salud, sino que también ejercerá una influencia positiva en la calidad de los cuidados y la atención que proporcionan a los pacientes en el ejercicio de su profesión.

Teniendo en cuenta lo anterior, y dada la necesidad de abordar el estrés mediante mecanismos naturales de prevención y recuperación de la salud con un enfoque integral, se planteó el objetivo de evaluar la efectividad de la auriculoterapia para la reducción del estrés en personal de salud de acuerdo a la mejor evidencia disponible.

Metodología

Para la elaboración de la presente revisión sistemática se siguieron los pasos del Manual Cochrane;

a) Formular pregunta y desarrollo de los criterios de inclusión, b) Búsqueda de estudios, c) Selección de estudios y obtención de los datos, d) Evaluación del riesgo de sesgo en los estudios



incluidos, e) Análisis de datos, f) Análisis de sesgo de informe, g) Presentación de los resultados, e h) Interpretación de los resultados y conclusiones.

En un primer lugar se emplearon los componentes Población, Intervención y Outcomes/resultados (PIO) para la formulación de la pregunta de investigación. Los elementos de la pregunta fueron identificados como: P= Personal de Salud, I= Auriculoterapia y O= Reducción del estrés. Es por ello, que la pregunta de revisión sistemática fue ¿Cuál es la efectividad de la auriculoterapia para la reducción del estrés en personal de salud de acuerdo a la mejor evidencia disponible?

Se incluyeron Ensayos Clínicos Aleatorios (ECA) entre 2012 y 2022 publicados en revistas indexadas en idioma español, portugués e inglés y estudios que incluyeron las variables de auriculoterapia y estrés en personal de salud. Se excluyeron artículos de metodología poco clara y dudosa, estudios de literatura gris (informes, documentos de trabajo, tesis, documentos gubernamentales) y estudios duplicados en las diferentes bases de datos.

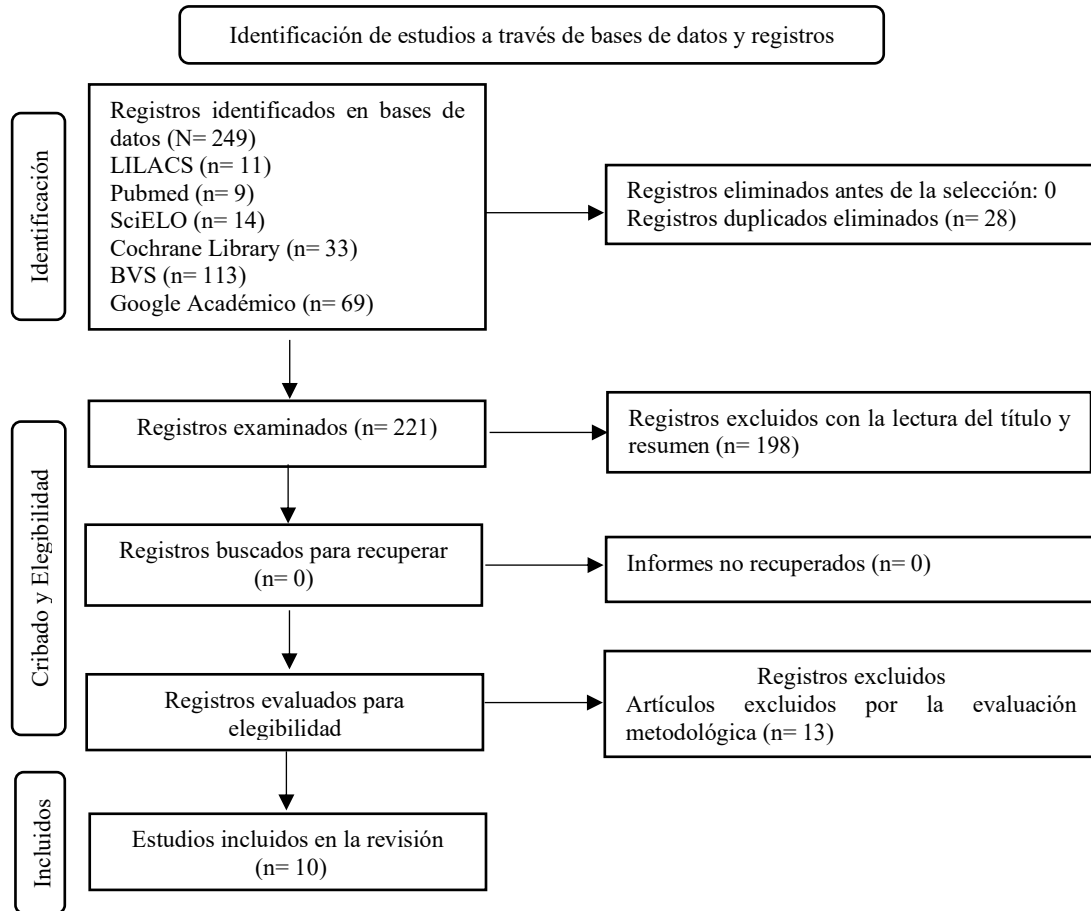
Para la estrategia de búsqueda, se utilizaron las bases de datos LILACS, PubMed, Cochrane Library, Scielo, Cochrane Library, Biblioteca Virtual en Salud (BVS) y en el buscador Google Académico. Se emplearon los operadores booleanos AND y OR, junto con los descriptores identificados en Medical Subject Headings (MeSH) y Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS). Las combinaciones empleadas fueron: Auriculotherapy AND stress AND nursing AND clinical trial, acupressure OR auriculotherapy AND stress AND nursing AND health personnel, y auriculotherapy OR ear acupuncture OR auricular acupuncture AND psychological stress OR stress.

Se identificaron un total de 249 artículos. Eliminándose aquellos que no cumplieron con los criterios de selección. Durante el análisis de la información se realizó lectura crítica y evaluación de los estudios mediante la lista de verificación de evaluación crítica del Joanna Briggs Institute ⁽²¹⁾ para ECA. Posteriormente se seleccionaron 10 estudios, llevando a cabo una síntesis descriptiva



de sus hallazgos, lo que permitió detallar sus características, considerando al autor, año de publicación, país, objetivos, hipótesis, muestra, resultados obtenidos, tasa de abandono de los participantes y efectividad de las intervenciones. Por último, se incluyó el diagrama de flujo PRISMA 2020, (Figura 1).

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA, 2024



Fuente: Elaboración propia

Resultados

Dentro de las características de los estudios se identificó que el 90 % fueron realizados en Brasil ^(5,6,18,22-27) mientras que el 10 % en Corea del Sur ⁽²⁰⁾. Respecto a la población el 90 % de los estudios incluyó profesionales de enfermería ^(5,6,18,20,22,24-27) y el 10 % alumnos de enfermería ⁽²³⁾. Por otro lado, otro estudio ⁽²⁴⁾ además de profesionales de enfermería incorporó a auxiliares y técnicos en

enfermería, otro investigador ⁽⁶⁾ abarcó una población más diversa, incluyendo técnicos de enfermería, dentistas, asistentes de salud bucal, personal de salud comunitaria y médicos, (Tabla 1).

Tabla 1. Características de los estudios incluidos, 2024 (n= 10)

Autor y Año	País	Revista	Población y Tamaño de la Muestra
Kurebayashi, et al. ⁽⁵⁾	Brasil	Rev. Esc. Enferm USP	Profesionales de enfermería (n= 75)
Kurebayashi, et al. ⁽²²⁾	Brasil	Acta Paul Enferm	Profesionales de enfermería (n= 49)
Prado, et al. ⁽²³⁾	Brasil	Rev. Latino-Am. Enfermagem	Alumnos de enfermería (n= 71)
Kurebayashi, et al. ⁽²⁴⁾	Brasil	Rev. Latino-Am. Enfermagem	Profesionales de enfermería, auxiliares y técnicos en enfermería (n= 75)
Kurebayashi, et al. ⁽²⁵⁾	Brasil	Rev. Eletr. Enfermero	Profesionales de enfermería (n= 75)
Kurebayashi, Da Silva ⁽¹⁸⁾	Brasil	Rev. Latino-Am. Enfermagem	Profesionales de enfermería (n= 175)
Kurebayashi, et al. ⁽²⁶⁾	Brasil	Rev. Bras Enferm.	Profesionales de enfermería (n= 175)
Prado, et al. ⁽²⁷⁾	Brasil	Rev. Esc. Enferm USP	Enfermeros (n= 168)
Lee, et al. ⁽²⁰⁾	Corea del Sur	Complementary Therapies in Clinical Practice	Enfermeras ambulatorias (n= 54)
Damasceno, et al. ⁽⁶⁾	Brasil	Rev. Latino-Am. Enfermagem	Enfermeras, técnicos de enfermería, dentistas, asistentes de salud bucal, salud comunitaria y médicos (n= 49).

Fuente: Elaboración propia

La tabla 2 expone las características de las intervenciones, detallando los tratamientos aplicados en los distintos puntos de auriculoterapia, material utilizado, tiempo de estimulación, el número, duración de las sesiones, y seguimiento posterior a las intervenciones. En cuanto a los resultados principales, los diferentes estudios revelaron que la auriculoterapia presentó mejor efectividad con agujas que con semillas ^(5,24,25). La auriculoterapia administrada por terapeutas en comparación con quienes no contaban con experiencia previa redujo de manera efectiva el estrés ⁽²²⁾. Dos estudios ^(23,27) demostraron que la auriculoterapia en comparación con el placebo fue más efectiva, contrario a un estudio ⁽²⁰⁾ que, a pesar de haber revelado una reducción del estrés, no mostró diferencias en el grupo experimental y el placebo. Mientras que, la auriculoterapia sin protocolo, es decir, individualizada, fue más efectiva para la reducción del estrés que la auriculoterapia con protocolo ⁽¹⁸⁾, en otro estudio se obtuvo lo contrario, ya que se informó una reducción del estrés tanto con la auriculoterapia con protocolo como sin protocolo.



Tabla 2. Características de las intervenciones, 2024 (n= 10)

Autor/Año	Objetivo	Intervenciones		Resultado principal
		Grupo experimental (GI)	Grupo control (GC)	
Kurebayashi, et al. ⁽⁵⁾	Evaluar los niveles de estrés en el equipo de enfermería de un hospital y analizar la eficacia de la auriculoterapia con agujas y semillas.	G2: agujas (n= 27) G3: semillas (n= 27)	G1: sin ninguna intervención (n= 22)	Los GI mostraron diferencias estadísticas ($p < 0.05$) a partir de la segunda evaluación. Se constató que la auriculoterapia redujo el estrés en los profesionales de enfermería, con mejores resultados con agujas que con semillas. Mientras que en GC no se encontraron resultados estadísticos significativos.
Kurebayashi, et al. ⁽²²⁾	Evaluar la eficacia de la auriculoterapia con agujas semipermanentes sobre los niveles de estrés en el personal de enfermería de un hospital.	G2: gujas semipermanentes con terapeutas experimentados (n= 16) G3: agujas semipermanentes con terapeutas experimentados (n= 17)	G1: sin ninguna intervención (n= 16)	Se observó diferencia estadística significativa entre G1 y G3 ($p = 0.036$), lo que demostró que la auriculoterapia administrada por terapeutas más experimentados redujo de manera efectiva el estrés en profesionales de enfermería.
Prado, et al. ⁽²³⁾	Evaluar la eficacia de la auriculoterapia verdadera y auriculoterapia placebo para reducir los niveles de estrés.	G1: auriculoterapia (n= 24)	G2: sin auriculoterapia (n= 25) G3: grupo placebo con puntos simulados (n= 22)	El G1 presentó índice de Cohen de 1.81 (efecto alto) y diferencia estadística después de 8 sesiones, mantenida en el seguimiento ($p < 0.001$). Demostrando que la auriculoterapia verdadera obtuvo mejor resultado para la reducción del estrés.
Kurebayashi, et al. ⁽²⁴⁾	Evaluar la auriculoterapia en la reducción del estrés y analizar las diferencias entre el antes y el después del tratamiento en los dominios de afrontamiento.	G2: agujas (n= 27) G3: semillas (n= 26)	G1: control (n= 22)	El G3 semilla no mostró diferencia estadística significativas en cuanto a niveles de estrés en comparación con otros grupos, pero si dentro del mismo grupo a lo largo del tiempo ($p < 0.05$). La auriculoterapia con agujas disminuyó niveles de estrés ($p < 0.05$). Mientras que en la cuarta evaluación hubo diferencia entre GC y G2 agujas en el dominio de distanciamiento ($p < 0.05$).
Kurebayashi, et al. ⁽²⁵⁾	Identificar los diagnósticos de la MTC para los síntomas de estrés que respondieron a la auriculoterapia	G2: agujas semipermanentes (n= 27) G3: semillas (n= 26)	G1: control sin tratamiento (n= 22)	Se encontraron diferencias estadísticas después del tratamiento ($p = 0.023$) entre G2 aguja y controles, mostrando que la auriculoterapia redujo el estrés con mejores resultados con agujas que con semillas.



Kurebayashi, Da Silva ⁽¹⁸⁾	Evaluar la eficacia de auriculoterapia con y sin protocolo para reducir los niveles de estrés en el personal de enfermería.	G2: auriculoterapia con protocolo (puntos específicos establecidos) con agujas semipermanentes (n= 58) G3: auriculoterapia sin protocolo (elegidos en función de los síntomas reportados en cada consulta) con agujas semipermanentes (n= 59)	G1: control (n= 58)	Se encontraron diferencias estadísticas entre GC y GI en las dos evaluaciones ($p < 0.05$). El G2 protocolo logró índice de 0.79 (gran efecto) con reducción media de los niveles de estrés (27 %). El G3 sin protocolo logró gran reducción del estrés (37 %) equivalente al índice de Cohen de 1.21 (efecto muy grande). Se demostró que la auriculoterapia sin protocolo (individualizada) redujo más el estrés en el personal de enfermería.
Kurebayashi, et al. ⁽²⁶⁾	Evaluar la efectividad de la auriculoterapia para mejorar la calidad de vida y reducir el estrés en el equipo de enfermería.	G2: auriculoterapia con protocolo (puntos específicos establecidos) con agujas semipermanentes (n= 58) G3: auriculoterapia sin protocolo (elegidos en función de los síntomas reportados en cada consulta) con agujas semipermanentes (n= 59)	G1: control (n= 58)	Se mostraron diferencias estadísticas en la lista de síntomas de estrés en la segunda evaluación entre GC y dos GI ($p = 0.000$) y en la tercera evaluación las diferencias fueron entre GC y protocolo ($p = 0.004$) y entre GC y sin protocolo ($p = 0.002$). Tanto GI con protocolo y sin protocolo redujeron el estrés ($p < 0.05$).
Prado, et al. ⁽²⁷⁾	Comprobar la eficacia de la auriculoterapia experimental y la auriculoterapia placebo con puntos simulados para el tratamiento del estrés en enfermeros de un hospital benéfico de São Paulo	G1: auriculoterapia	G2: placebo puntos simulados G3: control sin intervención	La auriculoterapia experimental logró reducción del estrés del 43 % presentando diferencia estadística después de 8 sesiones ($p < 0.001$). Mientras que la auriculoterapia placebo logró reducción del 26 %, logrando diferencia después de 12 sesiones ($p < 0.001$). Mientras que GC sin intervención no logró reducción del estrés.
Lee, et al. ⁽²⁰⁾	Examinar los efectos de la acupresión auricular sobre el estrés, la ansiedad y depresión de enfermeras ambulatorias.	G1: con semillas (n= 28)	G2: placebo con semillas (n= 26)	No se observó una reducción del estrés; sin embargo, se registró una disminución del cortisol. Aun así, no se encontraron diferencias estadísticas significativas entre GI y GC.

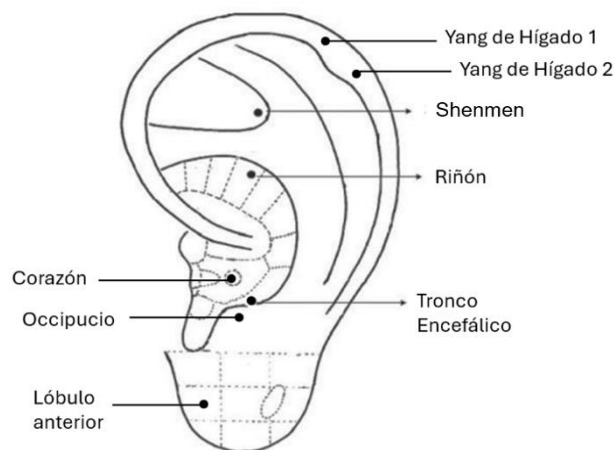


Damasceno, et al. ⁽⁶⁾	Evaluar la efectividad de la auriculoterapia en la reducción del estrés laboral entre trabajadores de la estrategia de salud de la familia durante la pandemia de COVI-19.	G1: auriculoterapia (n= 25)	G2: grupo placebo (n= 24)	El grupo de auriculoterapia presentó reducciones del estrés laboral.
----------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------	--

Fuente: Elaboración propia

Puntos de auriculoterapia, de acuerdo con los puntos estimulados en los grupos de intervención en el 100 % se utilizó el punto Shenmen ^(5,6,15,20,22-27), el 90 % de los estudios estimuló el punto de tronco encefálico ^(5,6,18,22-27), el 60 % riñón ^(5,18,22,24-26), 20 % hígado de yang 1 y 2 ^(18,26) y un 10 % en corazón, occipucio y lóbulo anterior ⁽²⁰⁾. Cabe destacar que en un estudio ⁽²⁷⁾ se utilizó el punto Shenmen en el 100 % de los participantes, lo que reafirmó su relevancia en la reducción del estrés, (Figura 2).

Figura 2. Puntos de auriculoterapia utilizados en los diferentes estudios



Fuente: Adaptado de Kurebayashi, et al. 2012 ⁽⁵⁾

Por otro lado, en el 30 % de los estudios del grupo control se estimularon el punto muñeca ^(6,20,23) y oído externo ^(6,23,27). En el 10 % en los puntos cara ⁽²⁷⁾, cadera, codo y hombro ⁽²⁰⁾. En un 20 % los puntos a estimular fueron elegidos conforme a los síntomas reportados por los participantes en cada consulta, según los diagnósticos de la MTC ^(18,26). De acuerdo con los estudios la efectividad

de la auriculoterapia se atribuyó a la estimulación de los puntos auriculares ^(5,18,26). En un estudio se explicó que el oído presenta una rica inervación y su estimulación activa mecanismos neurológicos mediados por el sistema nervioso parasimpático favoreciendo la liberación de neurotransmisores que actúan en el organismo ⁽²³⁾. De igual manera, en otro estudio ⁽⁵⁾ se detalló que los puntos estimulados son capaces de activar fibras nerviosas mielinizadas que envían impulsos a la columna vertebral, el cerebro, la hipófisis y el hipotálamo, provocando la liberación de endorfinas a la sangre.

Dispositivo/material, en lo que respecta al material o dispositivo empleado en la técnica de auriculoterapia, el 70 % de los estudios utilizó agujas semipermanentes ^(5,18,22-26). El 30 % semillas de mostaza ^(5,6,24). El 20 % semillas de vacaria ^(20,27) y un 10 % semillas no especificadas ⁽²⁵⁾. En este sentido, conocer los diferentes materiales empleados, permite conocer cuál de ellos es más efectivo para la reducción del estrés.

Duración de las sesiones empleadas en las intervenciones, se observó que el 40 % de los estudios realizaron un total de 8 sesiones, una por semana, con una duración de 5 a 10 minutos cada una ^(5,22,24,25). Igualmente, 12 sesiones (dos veces por semana) con duración de 5 a 10 min ^(18,23,24,27).

Por el contrario, un estudio ⁽²⁰⁾ implementó las sesiones una vez por semana durante 5 semanas en ambos grupos, sin embargo, no reportó reducción en el nivel de estrés. Los investigadores señalaron la necesidad de realizar un seguimiento mayor a 8 semanas para obtener resultados. A diferencia de otro estudio ⁽⁶⁾ que mencionó haber empleado entre 3 y 6 sesiones.

Instrucciones adicionales, que se brindaron en los diferentes estudios influyeron directamente sobre la efectividad que tendría la auriculoterapia durante la intervención. Por esta razón, cabe mencionar que en el 20 % se indicó a los participantes estimular las semillas tres veces al día con presión semi-moderada y retirar agujas 24 horas antes de la consulta o si se presentaban molestias como: prurito o alergia ^(5,24). Otro 20 % mencionó haber utilizado localizador de puntos ^(5,23). Un 10 %



indicó presionar las semillas de forma continua los 5 días durante 5 segundos con pausa de dos segundos durante 5 minutos, cuatro veces al día (7 am, 12 pm, 5 pm y 10 pm), posteriormente se instruyó retirar los puntos al sexto día y masajear ligeramente las orejas. Por añadidura, un 10 % utilizó cinta hipoalergénica ⁽¹⁸⁾, cinta de microporosa ⁽²⁶⁾, cinta adhesiva de microporos hipoalergénica ⁽⁶⁾. Mientras que investigadores ⁽²⁵⁾ hicieron hincapié en el lavado de manos con agua y jabón, (Tabla 4).

Tabla 4. Protocolo de intervención, 2024 (n= 10)

Autor/Año	Puntos de auriculoterapia	Dispositivo/material	Duración de las sesiones	Instrucciones adicionales
Kurebayashi, et al. ⁽⁵⁾	G2 y G3: Shenmen, riñón y tronco encefálico	Agujas semipermanentes y semillas de mostaza	G2 y G3: 8 sesiones (1 por semana) de 5 a 10 min.	Estimular las semillas tres veces al día con presión semi moderada y retirar agujas 24 horas antes de la consulta o si se presentaron molestias como: prurito o alergia.
Kurebayashi, et al. ⁽²²⁾	G2 y G3: Shenmen, riñón y tronco encefálico	Agujas semipermanentes	G2 y G3 recibieron ocho sesiones, 1 por semana con una duración de 5 a 10 minutos.	Se utilizó localizador de puntos
Prado, et al. ⁽²³⁾	G1: Shenmen y tronco encefálico G3: Muñeca y oído externo	Agujas semipermanentes	G1 y G3: 12 sesiones 1 por semana de 5 a 10 min.	Se utilizó localizador de puntos
Kurebayashi, et al. ⁽²⁴⁾	G2 y G3: Shenmen, riñón y tronco encefálico	Agujas semipermanentes y semillas de mostaza	G2 y G3: 8 sesiones (1 por semana) de 5 a 10 min.	Estimular las semillas tres veces al día con presión semi moderada y retirar agujas 24 horas antes de la consulta o si se presentaron molestias como: prurito o alergia.
Kurebayashi, et al. ⁽²⁵⁾	G2 y G3: Shenmen, riñón y tronco encefálico	Agujas esterilizadas y semillas	G2 y G3: 8 sesiones (1 por semana) de 5 a 10 min.	Lavado de manos con agua y jabón
Kurebayashi, Silva ⁽¹⁸⁾	G2: Shenmen, troco encefálico, riñón, hígado yang 1 y 2. G3: Los puntos fueron elegidos en función de los síntomas reportados en cada consulta, según los DX de la MTC.	Agujas semipermanentes	G2 y G3: 12 sesiones (dos veces por semana) con duración de 5 a 10 min.	Las agujas se aplicaron con cinta hipoalergénica



Kurebayashi, et al. ⁽²⁶⁾	G2: Shenmen, troco encefálico, riñón, hígado yang 1 y 2. G3: Los puntos fueron elegidos según la respuesta del sujeto al tratamiento.	Agujas semipermanentes	G2 y G3: 12 sesiones (dos veces por semana) con duración de 5 a 10 min.	Las agujas se aplicaron con cinta de microporos
Prado et al. ⁽²⁷⁾	G1: Shenmen y tronco encefálico G2: Área externa de la oreja y la cara	Semillas de vaccaria	12 sesiones dos veces por semana, seguimiento de 15 días.	
Lee, et al. ⁽²⁰⁾	G1: Shenmen, corazón, occipucio, lóbulo anterior. G2: Muñeca, cadera, codo, hombro.	Semillas de vaccaria	Una vez por semana durante 5 semanas en ambos grupos, además, se alterno la aplicación entre cada oído cada semana.	Presionaron las semillas de forma continua los 5 días, durante 5 segundos con pausa de dos segundos durante 5 minutos, cuatro veces al día (7 am, 12 pm, 5 pm y 10 pm). Se retiraron los puntos al sexto días y masajearon ligeramente las orejas.
Damasceno, et al. ⁽⁶⁾	G1: Shenmen y punto del tronco encefálico G2: Muñeca y oído externo	Semillas de mostaza	3, 6 sesiones.	Se utilizó cinta adhesiva de microporos hipoalergénica.

Fuente: Elaboración propia, Nota: G1= Grupo 1, G2= Grupo 2, G3= Grupo 3, DX=Diagnostico, MTC= Medicina Tradicional China.

Efectos Adversos, el 60 % de los estudios no reportaron efectos adversos en los participantes (6,18,20,24,26,27). Un estudio ⁽²³⁾ mencionó que uno de los participantes abandonó el estudio por hipersensibilidad y dolor en el área auricular. Por su parte, el 20 % de los estudios señaló que un participante recién sometido a cirugía bariátrica se retiró del estudio debido a que la auriculoterapia generó aumento de ansiedad por la comida e inquietud ^(5,25). Así mismo otro 20 % refirió que un participante se retiró a causa de presentar pesadillas luego de las aplicaciones de auriculoterapia, cabe destacar que laboraba durante la noche y recibía atención al finalizar el turno ^(22,25). Un estudio ⁽²⁴⁾ mencionó que algunos participantes presentaron incomodidad con la colocación y la permanencia de las aguas, sin generar mayores efectos adversos, salvo prurito, el cual se resolvió inmediatamente al cambiar las agujas por semillas.



Discusión

La revisión sistemática tuvo como objetivo de evaluar la efectividad de la auriculoterapia para la reducción del estrés en personal de salud de acuerdo a la mejor evidencia disponible, se logró identificar que los estudios indicaron que el personal de salud puede enfrentar estrés debido a las condiciones laborales a las que se ven expuestos. Este hallazgo coincide con lo mencionado por la Organización Mundial de la Salud ⁽²⁸⁾, que señala que los altos niveles de estrés impactan al personal de salud y de atención, como respuesta a la escasez de personal, salarios bajos, condiciones laborales inadecuadas e inseguras, ambientes extremadamente estresantes y la falta de las garantías laborales esenciales.

En cuanto al referente teórico, la auriculoterapia se fundamenta en los principios básicos de la MTC, la cual sostiene que el oído se encuentra conectado con 12 meridianos (canales energéticos por donde circula el Qi), y al estimular el oído contribuye a restablecer el equilibrio entre el Qi (energía vital) y la sangre ^(6,15). Con base en el fundamento teórico del estrés, Lazarus y Folkmann (1984), en su modelo transaccional, explican que este no depende solo de la situación en sí, sino de la evaluación subjetiva que la persona hace de ella. El estrés, surge cuando la persona continuamente valora las demandas del entorno y percibe que superan su capacidad de afrontamiento, generando respuestas psicológicas, fisiológicas y conductuales ⁽²⁹⁾. En este sentido, la estimulación de los puntos en el oído podría explicar la efectividad al reducir el estrés ya que al ser estimulados se generan conexiones reflejas con otras partes del cuerpo, a través de las vías neurales, que dan como resultados reflejos víscero-somáticos que buscan una acción homeostática sobre el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, responsable de la liberación de cortisol ⁽³⁰⁾.

Simultáneamente, durante la estimulación de los puntos, se activan pequeñas fibras nerviosas mielinizadas que transmiten impulsos hacia la columna espinal, el cerebro, la glándula pituitaria y el hipotálamo, lo que desencadena la liberación de endorfinas en el torrente sanguíneo generando



una sensación de alivio y bienestar⁽²²⁾. En ese caso, los hallazgos encontrados en los estudios sobre el estrés y la auriculoterapia indican que esta técnica proporciona beneficios para ayudar a reducir el estrés. Lo que se encuentra respaldado por los resultados de un metaanálisis⁽³⁰⁾ el cual mencionó que la auriculoterapia además de reducir los niveles de estrés en el personal de salud tiene efectividad en la reducción de la ansiedad.

En cuanto a los puntos de auriculoterapia, los más utilizados fueron Shenmen, el punto de tronco encefálico y punto del riñón, los cuales demostraron tener un efecto significativo sobre la reducción del estrés. Estos hallazgos coinciden con lo reportado por investigadores⁽³⁰⁾, quienes indicaron que, aunque no existió una estandarización en el uso de la auriculoterapia, sugieren la utilización de puntos como Shenmen, tronco encefálico, riñón, simpático, pulmón y hepáticos. Estos puntos, además, de ser empleados para la disminución del estrés, también pueden ser utilizados para tratar la ansiedad y el burnout en profesionales de la salud. Esto puede explicarse por el hecho de que se ha demostrado que el punto Shenmen tiene un efecto calmante, promoviendo la relajación y la sedación^(31,32). Por otro lado, el punto Riñón desempeña una función energética, mientras que el punto Tronco Encefálico posee propiedades calmantes⁽¹⁸⁾.

En lo que respecta al material o dispositivo empleado en la técnica de auriculoterapia, los estudios señalaron que las agujas semipermanentes tienen mayor efectividad en comparación con las semillas. El uso de agujas semipermanentes permite mantener los puntos activos de manera continua, sin necesidad de que el individuo realice una estimulación adicional. Este resultado concuerda con lo encontrado por investigadores⁽³⁰⁾ quienes mencionaron que las agujas semipermanentes fueron más efectivas para reducir los resultados evaluados que otros materiales o grupos, pues cuando se compara con grupos control o placebo, es eficaz para el estrés. Esto podría deberse debido a que las agujas semipermanentes en comparación con las semillas tienen una estimulación más constante y profunda.



El uso de semillas implica una serie de instrucciones adicionales para los participantes, lo que puede generar una variabilidad en los resultados ⁽³⁰⁾. Esto se debe a que, si los participantes olvidan estimular las semillas con la frecuencia y durante el indicado, la efectividad de la técnica podría disminuir. Conjuntamente la fuerza de presión que ejerzan los participantes sobre las semillas será diferente. Esto muestra que el uso de agujas implica menores instrucciones adicionales en comparación con las semillas. Las agujas, al ser aplicadas causan dolor e inflamación local, haciendo que el punto permanezca activo, sin necesidad de estimulación manual ⁽³³⁾.

La duración de las sesiones empleadas en las intervenciones que fueron efectivas incluyeron entre 8 a 12 sesiones, de 1 a 2 por semana, con una duración de 5 a 10 minutos cada una. Esto coincide con lo reportado en un estudio ⁽³⁰⁾ en el cual los investigadores sugirieron un tratamiento de ocho sesiones, una por semana. Esto refleja la falta de un protocolo estandarizado donde las sesiones, puntos de estimulación e instrucciones sean específicas y probados en investigaciones clínicas.

Este estudio únicamente presenta evidencia sobre la efectividad de la auriculoterapia en los distintos estudios, sin abordar comparaciones entre técnicas o protocolos. Esta limitación se debe a la heterogeneidad en la selección de puntos, los dispositivos y materiales utilizados, la duración de las sesiones, las instrucciones adicionales y los efectos adversos registrados durante las intervenciones lo cual puede atribuirse a que la técnica ha sido aplicada en distintos países. Los resultados de los estudios fueron variables, lo que limitó la posibilidad de realizar un metaanálisis. Asimismo, dado que esta revisión se basó en el marco PIO y no en un enfoque PICO, no se realizaron comparaciones entre las diferentes técnicas.

La ausencia de estudios en México que profundicen en la aceptación de la intervención y en su combinación con otras terapias dificulta evaluar cuál intervención resulta más efectiva para la reducción del estrés en el personal de salud. Se recomienda la elaboración y estandarización de un protocolo que sea probado y validado en población mexicana por personal de enfermería, en el cual



se consideren aspectos de higiene y bioseguridad ⁽³⁰⁾. Cabe destacar que el personal de enfermería desempeña un papel clave en el primer nivel de atención y tiene la responsabilidad de contribuir al desarrollo de estrategias innovadoras para el cuidado de la salud.

Conclusiones

La presente revisión muestra que la auriculoterapia es efectiva para la reducción del estrés en el personal de salud; empero, la falta de estudios y la ausencia de revisiones sistemáticas actualizadas dificultó evaluar y generalizar los resultados. No obstante, a partir de estos hallazgos, es posible realizar réplicas del estudio que contribuyan a fortalecer la investigación y el cuerpo de conocimientos de enfermería, pues resulta primordial la incorporación de alternativas como la auriculoterapia, que son mínimamente invasivas y presentan pocos efectos secundarios.

Por consiguiente, se requiere un consenso unánime entre los profesionales del área de la salud, especialmente del personal de enfermería, para impulsar investigaciones que promuevan la implementación de las PICS como prácticas alternativas y complementarias en la atención y el cuidado no solo del personal de salud, sino también de los pacientes, que tengan el potencial de fortalecer los mecanismos naturales de recuperación de la salud, tanto física como mental.

Por último, se recomienda la realización de estudios multicéntricos que comparen la auriculoterapia con otras PICS, permitiendo evaluar sus efectos a largo plazo y fomentando la generación de nuevas líneas de investigación en enfermería.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe ningún conflicto de intereses.

Financiamiento

La investigadora principal con número de CVU: 1109514, agradece la beca otorgada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) para la realización de



estudios de Doctorado en Ciencias en Enfermería con el Cuerpo Académico Salud Mental y Conductas de Riesgo en Población Vulnerable en la Facultad de Enfermería Mochis.

Inteligencia artificial

Los autores declaran que no han utilizado ningún tipo de recurso de la inteligencia artificial en alguna de las secciones de este manuscrito.

Referencias bibliográficas

1. Cajamarca KM, Guaita LV, Ocaña ME, Yansapanta EA, Gaibor JL. Estrés y manifestaciones psicosomáticas en el personal de salud: Stress and psychosomatic manifestations in health care personnel. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades [Internet]. 2023 [citado 20 jun 2024];4(1):2582 Disponible en: <http://dx.doi.org/10.56712/latam.v4i1.4382>.
2. Pintado JE, Suarez JA. Efectos del estrés laboral en la salud física y mental de trabajadores de la salud. Cienciamatria [Internet]. 2024 [citado 20 jun 2024];10(1):281-306. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9502294>
3. Couarraze S, Delamarre L, Marhar F, Quach B, Jiao J, Dorlhiac RA, The major worldwide stress of healthcare professionals during the first wave of the COVID-19 pandemic – the international COVISTRESS survey. PLoS ONE [Internet]. 2021 [citado 20 jun 2024];16(10):e0257840. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8494302/>
4. Baños RG, Barrientos SS, Arellano MA, Vega BA. Correlación entre estrés laboral y resiliencia en los médicos residentes de medicina familiar. Revista Mexicana de Medicina Familiar [Internet]. 2022 [citado 27 abr 2025];9(3):78-85 Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2696-12962022000300078
5. Kurebayashi LF, Gnatta JR, Borges TP, Belisse G, Coca S, Minami A, et al. Aplicabilidade da auriculoterapia com agulhas ou sementes para diminuição de estresse em profissionais de enfermagem. Rev Esc Enferm USP [Internet]. 2012 [citado 20 jun 2024];46(1):89-95. Disponible en: <https://doi.org/10.1590/S0080-62342012000100012>
6. Damasceno KS, Oliveira GM, Beltrame M, Coelho JM, Pimentel RF, Mercês MC. Effectiveness of auriculotherapy on stress reduction in health workers: a controlled randomized clinical trial. Rev Lat Am Enfermagem [Internet]. 2022 [citado 01 dic 2024];30:e3770. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.5992.3771>
7. Peter KA, Voirol C, Kunz S, Gurtner A, Renggli F, Juvet T, et al. Factors associated with health professionals' stress reactions, job satisfaction, intention to leave and health-related outcomes in acute care, rehabilitation and psychiatric hospitals, nursing homes and home care organisations. BMC Health Serv Res [Internet]. 2024 [citado 20 jun 2024];24(1):2-20. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s12913-024-10718-5>
8. Organización Mundial de la Salud (OMS). Estrés. Who.int. [Internet]. 2023 [citado 27 abr 2025]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/stress?gad_source=1



9. Chu B, Marwaha K, Sanvictores T, Awosika AO, Ayers D. Physiology, stress reaction [Internet]. Biblioteca Nacional de Medicina. StatPearls-NCBI Bookshelf; 2024 [citado 27 abr 2025]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541120/>
10. Instituto Nacional del Cáncer (INC). Estrés y cáncer [Internet]. INC.; 2024 [citado 13 jul 2024]. Disponible en: <https://www.cancer.gov/espanol/cancer/sobrellevar/sentimientos/hoja-informativa-estres>
11. National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH). Estrés. NCCIH [Internet]. 2024 [citado 13 jul 2024]. Disponible en: <https://www.nccih.nih.gov/health/espanol/estres>
12. Figueiredo IP, Umeoka EH. Stress: Influences and determinants of psychopathology. Enciclopedia. MDPI [Internet]. 2024 [citado 27 abr 2025];4(2):1026-1043. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2673-8392/4/2/66>
13. Bedoya EY. Estrés, regulación cognitivo-emocional, adaptación y salud en universitarios. Prax Saber [Internet]. 2021 [citado 02 sep 2024];12(30):e11534. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.19053/22160159.v12.n30.2021.115342>
14. Lucas AS, Fagundes ML, Júnior OL, Menegazzo GR, Giordani JM. Associação entre práticas integrativas e complementares em saúde e uso de serviços odontológicos em idosos no Brasil: estudo transversal, 2019. Epidemiol Serv Saude [Internet]. 2022 [citado 02 sep 2024];31(3):e2022314. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1590/s2237-96222022000300007>
15. Prado JM, Kurebayashi LF, Silva MJ. Auriculoterapia verdadeira e placebo para enfermeiros estressados: ensaio clínico randomizado. Rev Esc Enferm USP [Internet]. 2018 [citado 02 sep 2024]; 52(0):e03334. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1590/s1980-220x2017030403334>
16. Oliveira CM de, Assis BB de, Mendes PG, Lemos IC, Sousa AL, Chianca TC. Auriculoterapia em profissionais de enfermagem na pandemia do coronavírus: estudo de casos múltiplos. Rev Eletrônica Enferm [Internet]. 2021 [citado 19 nov 2024];23:65678. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5216/ree.v23.65678>
17. Jales R, Silva FV, Pereira IL, Gomes AL, Nogueira JA, Almeida SA. A auriculoterapia no controle da ansiedade e do estresse. Enferm Glob [Internet]. 2021 [citado 19 nov 2025];20(2):345-89. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1695-61412021000200011
18. Kurebayashi LF, Silva MJ. Efficacy of Chinese auriculotherapy for stress in nursing staff: a randomized clinical trial. Revista Latino-Americana de Enfermagem [Internet]. 2014 [citado 09 feb 2025];22(3):371-378. Disponible en: <https://doi.org/10.1590/0104-1169.3239.2426>
19. Corrêa HP, Moura C, Azevedo C, Bernardes MF, Mata LR, Chianca TC. Efeitos da auriculoterapia sobre o estresse, ansiedade e depressão em adultos e idosos: revisão sistemática. Revista da Escola de Enfermagem da USP [Internet]. 2020 [citado 28 nov 2024];54:e03626. Disponible en: <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2019006703626>
20. Lee SN, Kim B, Park H. The effects of auricular acupressure on stress, anxiety, and depression of outpatient nurses in South Korea. Complementary Therapies in Clinical Practice. [Internet]. 2021 [citado 28 nov 2024];44:101447. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34289443/>
21. Joanna Briggs Institute (JBI). Critical Appraisal Tools. JBI [Internet]. 2020 [citado 11 ene 2025]. Disponible en: <https://jbi.global/critical-appraisal-tools>
22. Kurebayashi LF, Gnatta JR, Borges TP, Silva MJ. Eficácia da auriculoterapia para estresse segundo experiência do terapeuta: ensaio clínico. Acta Paulista de Enfermagem. [Internet]. 2012 [citado 28 nov 2024];25(5):694-700. Disponible en: <https://doi.org/10.1590/S0103-21002012000500008>



23. Prado JM, Kurebayashi LF, Silva MJ. Efficacy of auriculotherapy for the reduction of stress in nursing students: a randomized clinical trial. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*. [Internet]. 2012 [citado 02 sep 2024];20(4):727-735. Disponible en: <https://doi.org/10.1590/S0104-11692012000400013>
24. Kurebayashi LF, Gnatta JR, Borges TP, Silva MJ. Applicability of auriculotherapy in reducing stress and as a coping strategy in nursing professionals. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*. [Internet]. 2012 [citado 09 feb 2025];20(5):980-987. Disponible en: <https://doi.org/10.1590/S0104-11692012000500021>
25. Kurebayashi LF, Gnatta JR, Borges TP, Silva MJ. Avaliação diagnóstica da medicina tradicional chinesa dos sintomas de estresse tratados pela auriculoterapia: ensaio clínico. *Revista Eletrônica de Enfermagem*. [Internet]. 2014 [citado 11 ene 2025];16(1):68-76. Disponible en: <https://doi.org/10.5216/ree.v16i1.20167>
26. Kurebayashi LF, Silva MJP da. Auriculoterapia Chinesa para melhoria de qualidade de vida de equipe de enfermagem. *Revista Brasileira de Enfermagem* [Internet]. 2015 [citado 03 dic 2024];68(1):117-123. Disponible en: <https://www.scielo.br/pdf/reben/v68n1/0034-7167-reben-68-01-0117.pdf>
27. Prado JM, Kurebayashi LF, Silva MJP. Auriculoterapia verdadeira e placebo para enfermeiros estressados: ensaio clínico randomizado. *Revista da Escola de Enfermagem da USP* [Internet]. 2018 [citado 01 dic 2024];52(0):e03334 Disponible en: <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2017030403334>
28. Organización Mundial de la Salud (OMS). Protecting health and care workers' mental health and well-being: Technical consultation meeting. WHO [Internet]. 2024 [citado 03 dic 2024]. Disponible en: https://www.who.int/news/item/25-04-2024-202404_protecthw_mentalhealth
29. Gómez OC, Cabrera FJ, Contreras GN, De la Roca CJ, Juárez MF. Modelo transaccional del estrés y estilos de afrontamiento en investigación psicológica del estrés: Análisis crítico. *Uaricha* [Internet]. 2024 [citado 08 sep 2025];22:42-53. Disponible en: <https://www.revistauaricha.umich.mx/index.php/urp/article/view/708>
30. Munhoz OL, Morais BX, Santos WM dos, Paula CC de, Magnago TS. Effectiveness of auriculotherapy for anxiety, stress or burnout in health professionals: a network meta-analysis. *Revista Latino-Americana de Enfermagem* [Internet]. 2022 [citado 17 sep 2024];30. Disponible en: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.6219.3708>
31. Kuo Y, Tsai SH, Chen SL, Tzeng YL. Auricular acupressure relieves anxiety and fatigue and reduces cortisol levels in post-caesarean section women: A single-blind, randomised controlled study. *International Journal of Nursing Studies*. [Internet]. 2016 [citado 17 sep 2024];53:17-26. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26525188/>
32. Arai YP, Sakakima Y, Kawanishi J, Nishihara M, Ito A, Tawada, Maruyama Y. Auricular Acupuncture at the “Shenmen” and “Point Zero” points induced parasympathetic activation. *Evidence-based Complementary and Alternative Medicine* [Internet]. 2013 [citado 28 abr 2025];1-4. Disponible en: <https://doi.org/10.1155/2013/945063>
33. De Castro MC, De Cássia LC, Cardoso AC, Nogueira DA, Azevedo C, Chianca TC. Acupuntura auricular para dor crônica nas costas em adultos: revisão sistemática e metanálise. *Revista Da Escola de Enfermagem Da USP* [Internet]. 2019 [citado 12 sep 2025];19;53:e03461. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31433010/>

Valenzuela-Urrea G, Ahumada-Cortez J, Gámez-Medina M, Apodaca-Armenta R, Gómez-Rodríguez G. Efectividad de la auriculoterapia para reducción del estrés en personal de salud una revisión sistemática. *SANUS* [Internet]. 2025 [citado dd mmm aaaa];10(21):e561 Disponible en: DOI/URL

